

Fecha Última Actualización: 13-09-2022 22:30:47

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Maria Veronica Cuminao Espinoza
Edad : 61a 10m 6d
Dirección : Salvaterra 1684

Rut : 9.166.085-7
Fecha Nacto: 07/11/1960
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1800507
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 8609 0701

N° Epicrisis
320915

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Hospitalizacion

Fecha Ingreso : 27/08/2022 14:53

Días Estadía: 17

Unidad de Egreso : Utim (5to Piso Mater)

Fecha Egreso : 13/09/2022 22:09

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

desorientación

Comorbilidades

Procedimientos

09/09/2022 - Paracentesis Evacuadora

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Antecedentes:

Médicos:

- Daño hepático crónico (DHC) Child B/ MELD Na 19, etiología OH vs NASH. Complicaciones: Ascitis, sin PBE; EH grado I-II, VE pequeñas sin sangrado previo.
- Enfermedad ulcerosa péptica con HDA previa.-
- ERC etapa IIIB. Crea basal 1.1 mg/dL (agosto 2022), Proteinuria 2.6 g/24 hrs (marzo 2021) obs nefropatía IgA, sin biopsia renal.
- ITU recurrente.
- Crisis convulsiva reactiva (07/2022).
- Tumor anexial derecho en seguimiento por onco-ginecología.
- Atresia congénita del conducto auditivo derecho.

Quirúrgicos: Hernioplastia umbilical, colecistectomía.

Fármacos: Levetiracetam 1 gr c/12 hrs, Ácido Fólico 5 mg/día, Lactulosa 40 cc c/8 hrs, Rifaximina 400 mg c/8 hrs, Bicarbonato de sodio 1 gr c/12 hrs, Amlodipino 5 mg/día, Omeprazol 20 mg/día.

Alergias: (-)

Hábitos: OH consumo perjudicial por 40 años suspendido en 2014. TBQ (-).

Sociales: previamente autovalente, dueña de casa. Esposo Carlos +59686090701.

Hospitalizaciones recientes:

- 14/08/22 ¿ 19/08/22 : EH y HDA no variceal.
- 11/07/22-11/08/22: EH, HDA no variceal. Crisis convulsiva interpretada como reactiva. VMI en contexto de CC. NAVM por KPN BLEE, portación .E faecium VAN B.
- 05/02-22/02 y 12/04-22/04/22: EH, AKI sobre ERC. ITU K. pneumoniae BLEE
- 21/01-03/02/22: EH, COVID-19, AKI sobre ERC
- 29/12-06/01 y 11/01-27/01/22: EH, AKI sobre ERC, ITU K. pneumoniae BLEE.

Motivo de consulta: Compromiso de conciencia.

Anamnesis próxima

Paciente con antecedentes descritos, consulta por cuadro de 2 días de compromiso de conciencia cualicuantitativo hasta sopor

Fecha Epicrisis : 13/09/2022 22:30

Página 1 de 2

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:22

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 13-09-2022 22:30:47

Página 2 de 2

superficial en relación a constipación. Sin fiebre, síntomas respiratorios, urinarias ni gastrointestinales. Ingres a estable hemodinámicamente, somnolienta, sin focalidad infecciosa, TR sin sangre o fecaloma. Exámenes de laboratorio sin falla renal, parámetros inflamatorios bajos, destaca SO inflamatorio y UC (+) para KPN BLEE sensible a amikacina e imipenem. TAC de cerebro sin complicaciones agudas, TAC TAP con ascitis y derrame pleural bilateral moderado, sin focos infecciosos. Ingres a UTIM para continuar manejo.

Evolución

Completa 10 días de tratamiento antibiótico con imipenem y luego amikacina. Evoluciona favorable del punto de vista de conciencia hasta lograr vigilia pero con falla renal progresiva que se interpretó como NTI por amikacina dado falta de respuesta a volemicación vigorosa. En dicho contexto evoluciona congestiva, febril, con falla respiratoria. Se maneja con VMNI, terapia diurética y antibióticos de segunda línea con deterioro progresivo del punto de vista ventilatorio y renal, oligoanúrica. Dado paciente deteriorada fisiológicamente, sin respuesta a terapia, en conjunto con familia se decide adecuar esfuerzo terapéutico y priorizar medidas de confort. Paciente fallece el 13 de septiembre a las 21:58 hrs. Se avisa a esposo y se realiza certificado de defunción.

Diagnóstico de Egreso

Encefalopatía tóxica- metabólica -
FIBROSIS Y CIRROSIS DEL HIGADO -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente fallece el 13 de septiembre a las 21:58 hrs. Se avisa a esposo y se realiza certificado de defunción.

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo Asistido

Régimen Alimentario : Hiposódico

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Felipe Vargas Campos
Becado/Residente



Camila Daniela Vargas Munoz
Médico Tratante (Staff)